

Finalità del Lavoro Sociale: autonomia, empowerment, benessere, qualità di vita, PERMA

TMIS · Sessione 03

Questa lezione è una delle fondamenta del corso: ti dà il vocabolario del lavoro sociale. Non sono parole d'effetto — sono le bussole che orientano ogni intervento. Capirle bene significa capire *perché* esiste questa professione e dove vuole portare le persone.

Le finalità dell'operatore sociale: panoramica

Prima di entrare nei singoli concetti, la lezione ha dedicato ampio spazio a una domanda apparentemente semplice ma insidiosa: *cosa sono le finalità del lavoro sociale, e cosa invece sono solo strumenti?*

I gruppi di studenti hanno presentato diverse proposte — autonomia, fiducia, ascolto attivo, accompagnamento, benessere, inclusione, integrazione. La professoressa ha poi guidato la distinzione: l'ascolto attivo, per esempio, è uno **strumento** per raggiungere la finalità. L'autonomia o il benessere sono **finalità** — le mete verso cui si tende.

Il punto chiave che è emerso dalla discussione: si lavora **con** le persone, non **per** le persone. Non ci si sostituisce alla persona — la si accompagna perché possa fare da sola. L'obiettivo ideale dell'operatore sociale? Come ha detto una docente: **diventare inutile**. Lavorare così bene da non essere più necessari.

Un altro punto interessante sollevato dalla classe: non è solo il risultato finale che conta, ma anche **il processo**. La ricerca della soluzione, fatta insieme alla persona, può essere già parte della soluzione stessa.

Qualità di Vita (QdV): il modello multidimensionale

Definizione

Il concetto di **Qualità di Vita** è studiato da molte discipline e ogni disciplina ha sviluppato una propria prospettiva. Nel lavoro sociale, il riferimento principale è il modello di **Schalock e Verdugo** (2006/2008).

L'OMS (1995) definisce la QdV come:

«La percezione dell'individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito, e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi.»

Una definizione più operativa è quella di Renwick e Brown: *il grado in cui una persona usufruisce a pieno delle possibilità/opportunità importanti della sua vita.*

Nota la parola chiave in entrambe: **percezione**. La QdV non è misurabile solo dall'esterno — dipende da come la persona vive la propria situazione.

Gli 8 domini della QdV

Schalock e Verdugo identificano otto dimensioni organizzate in tre aree trasversali:

Area trasversale	Dominio	Indicatori principali
Indipendenza	Sviluppo personale	Educazione, abilità, comportamento adattivo
Indipendenza	Autodeterminazione	Scelte, autonomia, controllo personale, obiettivi
Partecipazione sociale	Relazioni interpersonali	Rete sociale, amicizie, attività sociali
Partecipazione sociale	Inclusione sociale	Integrazione/partecipazione nella comunità

Area trasversale	Dominio	Indicatori principali
Partecipazione sociale	Diritti	Umani (dignità, uguaglianza) e legali
Benessere	Benessere emozionale	Sicurezza, esperienze positive, concetto di sé
Benessere	Benessere fisico	Salute, nutrizione, esercizio fisico
Benessere	Benessere materiale	Stato finanziario, lavorativo, abitativo

Pensa a questi domini come le radici di un albero: se una radice non sta bene, tutto l'albero ne risente. Non puoi guardare solo il tronco e pensare di capire la salute dell'albero.

I 7 principi del paradigma QdV

(Carbonari, 2017; Schalock e Verdugo)

1. **Multidimensionalità** — superamento degli approcci unidimensionali (es. "chi sta bene è chi ha soldi")
2. **Visione olistica** — i domini si influenzano reciprocamente; ogni modifica in un dominio ha effetti trasversali
3. **Temporalità** — i valori attribuiti variano nel corso della vita (prospettiva longitudinale)
4. **Variabilità personale** — ogni persona dà importanza diversa ai singoli domini
5. **Soggettività + oggettività** — vanno considerati sia elementi oggettivi (reddito, salute fisica) sia la narrazione soggettiva della persona
6. **Empowerment** — aspetti legati all'emancipazione e alla partecipazione attiva
7. **Estendibilità** — il modello vale per **tutte le persone**, non solo per quelle con disabilità

La professoressa ha sottolineato con un esempio molto concreto: una persona con ADHD in una società caotica può vivere la sua condizione come meno invalidante

che in una società rigidamente strutturata. Il contesto sociale **co-costruisce** la qualità di vita.

Salute e malattia: una visione tripartita

La definizione dell'OMS

La Carta di Ottawa (1986) definisce la salute come:

«Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità.»

La salute non è uno scopo in sé — è una **risorsa per la vita quotidiana**. Un mezzo, non un fine. La pace, le risorse economiche, il cibo, l'abitazione, un ecosistema stabile sono pre-requisiti necessari per la salute — che quindi non è solo una questione individuale, ma un diritto sociale.

Come ha sottolineato la classe: questa definizione del 1948 è ancora rivoluzionaria. Implica che pochissimi di noi siano "in salute" se intendiamo la salute come stato di **completo** benessere.

Il concetto triadico di Twaddle: disease, illness, sickness

Questa è una distinzione fondamentale per il lavoro sociale — imprimila bene.

- **Disease** — la malattia biologica oggettiva, quella che il medico diagnostica con sintomi e segni clinici
- **Illness** — il vissuto soggettivo del mal-stare, la percezione personale mediata anche dal background culturale
- **Sickness** — l'interpretazione sociale e culturale della malattia, con i diritti e gli obblighi che ne derivano

Esempio pratico: due persone con la stessa diagnosi (disease uguale) possono vivere la malattia in modo completamente diverso (illness diversa) e ricevere risposte diverse dalla società (sickness diversa). L'esperienza umana costruisce la malattia in tutti i suoi aspetti.

Benessere collettivo

Il benessere non è solo individuale. Secondo Dal Pra Ponticelli (2007), il **benessere collettivo** è:

«Sensazione positiva collettiva determinata dalla percezione di sentirsi riconosciuti come collettività, di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita sociale, poter usufruire di beni, servizi e di condividere una solidarietà sociale.»

Quindi anche lavorare per il benessere del singolo richiede, in parallelo, di lavorare per una società più equa e inclusiva.

Modello PERMA: il benessere individuale secondo Seligman

Martin Seligman — fondatore della **psicologia positiva** — ha sviluppato nel 2011 il modello PERMA per descrivere il benessere individuale come **flourishing** (funzionamento ottimale: stare bene e funzionare efficacemente).

Il PERMA nasce dopo una revisione critica della sua prima "Teoria della felicità autentica" (2002): Seligman si rende conto che la felicità è un termine troppo limitante, e che il vero obiettivo non è la soddisfazione di vita soggettiva, ma un costrutto più ampio e multidimensionale.

Lettera	Elemento	Descrizione
P	Positive Emotions — Emozioni positive	Atteggiamento positivo verso passato (orgoglio), presente (gioia), futuro (speranza)
E	Engagement — Coinvolgimento	Essere completamente presenti in ciò che si fa; il concetto di flow (la sensazione di essere nel flusso, che il tempo vola)
R		

Lettera	Elemento	Descrizione
	Relationships — Relazioni positive	Costruire legami forti con familiari, amici, colleghi; impatto diretto su salute e resilienza
M	Meaning — Significato	Sentire che la propria vita ha un senso; credere in qualcosa di più grande di sé (missione, comunità, fede)
A	Accomplishment — Realizzazione	Consapevolezza di aver raggiunto traguardi; alimenta autostima e ottimismo (principio di autoefficacia)

Pensa al PERMA come ai cinque pilastri di un edificio: se ne manca uno, la struttura è meno stabile. Nel lavoro sociale, promuovere il flourishing significa lavorare su più di questi pilastri contemporaneamente.

Empowerment: dal potenziamento individuale all'approccio relazionale

Definizione dell'OMS

«L'empowerment è un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni.»

Il termine nasce dai movimenti di emancipazione afroamericani negli Stati Uniti — ha origini politiche e conflittuali, non burocratiche. Oggi viene usato in modo più soft, ma è importante ricordare la radice: è un concetto legato al **potere** e alla possibilità di esercitarlo.

Empowerment individuale vs. di comunità

- **Empowerment individuale** — capacità del singolo di prendere decisioni e assumere il controllo della propria vita
- **Empowerment di comunità** — individui che agiscono collettivamente per influenzare i determinanti di salute e QdV nella propria comunità

L'approccio postmoderno: empowerment relazionale

Folgheraiter (2004) introduce il concetto di **empowerment relazionale**, legato al lavoro di rete:

Processo collaborativo di apprendimento reciproco volto alla valorizzazione delle potenzialità degli individui e delle collettività, per accrescerne la possibilità di autodeterminazione.

In questo approccio: - Gli esperti **cedono** parte del loro potere di trovare soluzioni alle persone con cui lavorano - L'utente diventa un **agente attivo** (non passivo ricevente di cure) - Il ruolo dell'operatore diventa di **orientamento, accompagnamento e sostegno** — non di sostituzione direttiva - Il cedere potere non è una perdita: quando il potere è scambiato e intrecciato, si **ri-genera e si moltiplica**

Principi operativi dell'empowerment relazionale (Folgheraiter): 1. Processo collaborativo: utenti, carer, operatori come partner 2. Utenti visti come potenzialmente competenti e capaci di decidere 3. Utenti capaci di autopercepirsi come agenti di cambiamento 4. Competenza acquisita attraverso l'esperienza, non ceduta dall'operatore 5. Operatori che non sostituiscono, ma **aspettano, sostengono e orientano** l'azione

Autonomia: non uno stato, ma un processo

Definizione (Tramma, 2018)

«La condizione di chi ha la capacità di organizzare le proprie azioni, scelte, comportamenti, tenendo conto di se stessi e dei fattori che entrano

in gioco nel proprio ambito esperienziale, nella complessa rete di dipendenze funzionali che lega il soggetto agli altri.»

Etimologicamente: dal greco *autos* (se stesso) + *nomos* (legge) = governarsi con leggi proprie.

Attenzione: autonomia non significa **isolamento** o **assenza di dipendenza**.

Nessun essere umano è autonomo in senso assoluto — tutti siamo inseriti in reti di dipendenze funzionali con gli altri.

Autonomia come processo (Meirieu)

Il pedagogo Philippe Meirieu propone di parlare di **processo di autonomizzazione** — non si "è" autonomi, ci si "diventa" progressivamente.

L'operatore deve:

«Sforzarsi di rendere il soggetto autonomo. Non supporlo già autonomo, ma organizzare un sistema di aiuti che gli permetta di raggiungere gli obiettivi che si fissa, prima di portarlo a fare progressivamente a meno di questi aiuti e ad applicare per conto suo, di sua iniziativa e in altre situazioni quello che ha acquisito.»

Il livello di autonomia deve sempre essere: - Definito a partire dal livello già raggiunto dalla persona - Un livello **superiore** ma **accessibile** (come salire un gradino alla volta, non tutta la scala in un colpo)

La finta autonomia e l'abbandono (Tramma, 2018)

Tramma segnala un rischio importante: confondere la vera autonomia raggiunta con la **finta autonomia** che maschera l'abbandono del servizio. In un momento di crisi del welfare state, c'è il rischio di usare il "fare da sé" come pretesto per ridurre i servizi, non per promuovere la crescita della persona.

Può essere necessario limitare l'autonomia?

Sì — in alcuni casi (protezione dei minori, situazioni di pericolo) limitare temporaneamente l'autonomia serve per **raggiungere una maggiore**

autonomia nel lungo termine. Non è una contraddizione: è una scelta educativa consapevole e contestualizzata.

Autostima vs. Autoefficacia: due concetti distinti

Questi due termini vengono spesso confusi — per l'esame è fondamentale conoscere la differenza.

Autostima

Dal latino *aestimare* = determinare il valore di. L'autostima è il **giudizio di valore personale** — come mi valuto come persona.

È determinata da: - Le aspettative dell'individuo su sé stesso - La raggiungibilità dei modelli di riferimento - La qualità delle relazioni sperimentate - I feedback ricevuti in ambito sociale, lavorativo, affettivo

Autoefficacia (Bandura, 2012)

«Le convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati.»

L'autoefficacia è il **giudizio di capacità personale** in uno specifico contesto — "sono capace di fare *questa cosa* in *questa situazione*?"

È il **motore motivazionale** dell'agentività umana: se penso di non essere capace di produrre un effetto su una situazione, non investo energie nell'azione. Non è una misura delle competenze possedute, ma della **credenza** in ciò che sono in grado di fare.

La differenza chiave (Bandura)

	Autostima	Autoefficacia
Domanda	"Quanto valgo come persona?"	"Sono capace di fare questa cosa?"

	Autostima	Autoefficacia
Tipo di giudizio	Valore personale	Capacità specifica
Ambito	Globale	Specifico per attività/contesto
Esempio	"Sono una persona di valore"	"Riuscirò a passare questo esame"

Esempio della professoressa: posso essere bravissima con Excel (alta autoefficacia in quel dominio) senza che questo mi dia autostima — se per me quel dominio non ha valore. Viceversa, posso non saper disegnare (bassa autoefficacia nel disegno) senza che questo intacchi il mio valore di persona.

Concetti chiave

Termine	Significato
Qualità di Vita (QdV)	Multidimensionale; percezione soggettiva della propria posizione rispetto a 8 domini (Schalock e Verdugo)
Flourishing	Funzionamento ottimale: stare bene e funzionare efficacemente (Seligman)
PERMA	Modello del benessere: Emozioni positive, Engagement, Relazioni, Significato, Realizzazione
Flow	Stato di massimo coinvolgimento e assorbimento in un'attività (componente E del PERMA)
Empowerment	Processo di acquisizione di potere decisionale sulla propria vita, individuale e collettivo
Empowerment relazionale	Approccio postmoderno: potere condiviso tra operatori e utenti come partner (Folgheraiter)
Autonomia	

Termine	Significato
	Capacità di governarsi con leggi proprie nella rete di dipendenze; processo, non stato fisso
Processo di autonomizzazione	Percorso graduale verso l'autonomia (Meirieu)
Autostima	Giudizio di valore personale (Bandura)
Autoefficacia	Giudizio di capacità personale in un dominio specifico (Bandura)
Disease	Malattia biologica oggettiva (Twaddle)
Illness	Vissuto soggettivo del mal-stare (Twaddle)
Sickness	Interpretazione sociale/culturale della malattia (Twaddle)

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** il concetto di autonomia e di lavoro *con* le persone richiama la definizione di lavoro sociale e il principio del rispetto dell'autodeterminazione (Lezione 01–02)
- **Temi aperti / da approfondire:**
 - Il conflitto tra autonomia individuale e autonomia collettiva (es. come gestire quando l'autonomia del singolo entra in contrasto con il benessere della comunità?)
 - Il confine tra vera autonomia e abbandono mascherato da "fare da sé"
 - Come misurare la QdV in pratica (strumenti di osservazione e valutazione)
 - L'empowerment relazionale nel progetto individuale: come si traduce operativamente?